BÓNUS INCLUÍDO · ELECTROMAPAS FISIOTERAPIA

KIT CLÍNICO PRO: 25 TESTES ORTOPÉDICOS + FICHAS DE AVALIAÇÃO

Guia Rápido dos 25 Testes Ortopédicos Mais Usados por Região Corporal,
Ficha de Avaliação Ortopédica Completa e Termo de Consentimento para Eletroterapia

O QUE ENCONTRAS NESTE GUIA PRÁTICO:

- ✓ **25 Testes Ortopédicos Essenciais por Articulação**
  Execução passo a passo, o que indica o teste positivo e com qual Mapa de Elétrodos cruzar.
- ✓ **Coluna Cervical, Lombar e Sacroilíaca**
  Spurling, Lasègue, Slump Test, Patrick-FABER e Gaenslen explicados de forma direta.
- ✓ **Ombro, Cotovelo, Punho e Mão**
  Neer, Hawkins-Kennedy, Jobe, Cozen, Mill, Phalen e Finkelstein para diagnóstico funcional.
- ✓ **Anca, Joelho, Tornozelo e Pé**
  Thomas, Ober, Lachman, Gaveta, McMurray, Thompson e Gaveta Anterior do Tornozelo.
- ✓ **Ficha de Avaliação + Termo de Consentimento Informado**
  Modelos prontos a imprimir para blindar o teu registo clínico e jurídico.

Autor: Jel Vitor — Coleção Oficial ElectroMapas Fisioterapia

Edição Digital em Alta Definição · 10 Páginas · Pronto para Consulta no Telemóvel, Tablet ou Impressão

Material de apoio visual · não substitui avaliação clínica nem indicações do fabricante

1. Testes Ortopédicos — Ombro (Coifa dos Rotadores e Impacto)

Confirmação funcional rápida antes de selecionar o Mapa de Elétrodos do Ombro.

Nome do Teste	Estrutura Avaliada	Como Executar e Sinal Positivo	Mapa de Elétrodos Recomendado
Teste de Jobe (Empty Can)	Tendão Supraespinhoso	Abdução 90° no plano da escápula + rot. interna contra resistência -> Dor/fraqueza	Mapa Ombro — Supraespinhoso / Coifa
Teste de Neer	Impacto Subacromial / Bursa	Elevação passiva máxima do braço em rotação interna com escápula estabilizada -> Dor	Mapa Ombro — Analgesia Global (Cruzado)
Hawkins-Kennedy	Impacto Subacromial	Ombro e cotovelo a 90°; realizar rotação interna passiva forçada -> Dor subacromial	Mapa Ombro — Face Anterior/Lateral
Teste de Gerber (Lift-off)	Músculo Subescapular	Dorso da mão na região lombar; afastar a mão das costas contra resistência -> Incapacidade	Mapa Escápula / Ombro Posterior
Teste de Speed (Palm-up)	Cabo Longo do Bíceps	Flexão anterior do ombro com cotovelo estendido e antebraço supinado -> Dor no sulco	Mapa Ombro Anterior / Bíceps Braquial
Teste de Apreensão	Instabilidade Anterior	Abdução 90° + rotação externa máxima em decúbito dorsal -> Receio de luxação	Mapa Reforço Deltoide / Estabilizadores

PONTO DE ATENÇÃO CLÍNICA E SEGURANÇA:

Sempre avalie primeiro o lado assintomático para estabelecer o padrão de força e amplitude basal do paciente.

© Todos os direitos reservados

2. Testes Ortopédicos — Cotovelo, Punho e Mão

Diferenciação rápida entre epicondilites, tenossinovites e compressões nervosas.

Nome do Teste	Estrutura Avaliada	Como Executar e Sinal Positivo	Mapa de Elétrodos Recomendado
Teste de Cozen	Epicondilite Lateral	Punho em extensão radial contra resistência com cotovelo a 90° -> Dor no epicôndilo lateral	Mapa Cotovelo — Epicondilite Lateral
Teste de Mill	Extensores do Carpo	Alongamento passivo: pronação + flexão do punho + extensão do cotovelo -> Dor lateral	Mapa Antebraço Dorsal / Extensores
Cotovelo de Golfista	Epicondilite Medial	Flexão palmar do punho contra resistência e supinação -> Dor no epicôndilo medial	Mapa Cotovelo — Epicondilite Medial
Teste de Finkelstein	Tenossinovite De Quervain	Polegar fechado dentro dos outros dedos + desvio ulnar passivo -> Dor estilóide radial	Mapa Punho Radial / Polegar
Teste de Phalen	Síndrome Túnel Cárpico	Flexão máxima de ambos os punhos (dorso com dorso) por 60 segundos -> Parestesia 1º–3º dedos	Mapa Punho / Canal Cárpico (TENS)
Sinal de Tinel no Punho	Nervo Mediano	Percussão leve sobre o retináculo dos flexores -> Choque irradiado para os dedos	Mapa Antebraço Ventral / Punho

PONTO DE ATENÇÃO CLÍNICA E SEGURANÇA:

Quando Phalen e Tinel forem positivos com perda de força de pinça tenar, priorize TENS convencional (sensorial suave) e evite contrações motoras intensas sobre o túnel cárpico.

© Todos os direitos reservados

3. Testes Ortopédicos — Coluna Cervical, Lombar e Sacroilíaca

Triagem de radiculopatias, dor facetária e disfunção sacroilíaca.

Nome do Teste	Estrutura Avaliada	Como Executar e Sinal Positivo	Mapa de Elétrodos Recomendado
Teste de Spurling	Compressão Radicular Cervical	Inclinação lateral + extensão da cabeça + compressão axial leve -> Dor irradiada ao braço	Mapa Cervical + Trapézio Superior
Teste de Tração Cervical	Alívio Radicular / Facetário	Tração manual cefálica suave em decúbito dorsal -> Alívio imediato da dor irradiada	Mapa Cervical Paravertebral Bilateral
Teste de Lasègue (SLR)	Nervo Ciático / Raiz L4–S1	Elevação da perna estendida em decúbito dorsal -> Dor radicular entre 30° e 70°	Mapa Ciatalgia (Lombar + Glúteo/Coxa)
Slump Test	Tensão Neural Neuroeixo	Sentado: flexão dorsal + cervical + extensão do joelho + dorsiflexão -> Reproduz sintomas	Mapa Lombar Baixa + Trajeto Ciático
Patrick (FABER)	Anca vs. Artic. Sacroilíaca	Flexão + Abdução + Rot. Externa (4) -> Dor inguinal (Anca) ou posterior (Sacroilíaca)	Mapa Sacroilíaca ou Região Glútea
Teste de Kemp	Dor Facetária Lombar	Extensão + rotação + inclinação ipsilateral em pé -> Dor localizada paravertebral	Mapa Lombar Cruzado (4 Elétrodos)

PONTO DE ATENÇÃO CLÍNICA E SEGURANÇA:

Sinal de Alerta (Red Flag): perda progressiva de força motora (pé caído) ou alterações esfincterianas (cauda equina) exigem encaminhamento médico imediato.

© Todos os direitos reservados

4. Testes Ortopédicos — Anca e Coxa

Avaliação de encurtamentos musculares, impacto femoroacetabular e síndrome do piriforme.

Nome do Teste	Estrutura Avaliada	Como Executar e Sinal Positivo	Mapa de Elétrodos Recomendado
Teste de Thomas	Contratura Iliopsoas / Reto Fem.	Abraçar um joelho ao peito em decúbito dorsal -> Coxa oposta sobe da marquesa	Mapa Coxa Anterior / Quadríceps
Teste de Ober	Trato Iliotibial / TFL	Decúbito lateral: abduzir e estender a anca e deixar cair em adução -> Coxa não desce	Mapa Lateral da Coxa / Trocânter
Teste de FADDIR	Impacto Femoroacetabular	Flexão 90° + Adução + Rotação Interna passiva da anca -> Dor profunda na virilha	Mapa Anca / Região Glútea
Teste de FAIR (Piriforme)	Síndrome do Piriforme	Decúbito lateral: Flexão 60° + Adução + Rotação Interna -> Dor no glúteo/ciático	Mapa Glúteo Profundo / Piriforme
Trendelenburg	Força do Glúteo Médio	Apoio unipodal -> Queda da hemipelve contralateral por fraqueza abdutora	Mapa NMES Glúteo Médio (Reforço)
Teste de Ely	Encurtamento Reto Femoral	Decúbito ventral: flexão passiva do joelho -> Elevação compensatória da pelve	Mapa Reto Femoral + Vastos

PONTO DE ATENÇÃO CLÍNICA E SEGURANÇA:

No Trendelenburg positivo, utilize o Mapa de Glúteo Médio em modo NMES/FES associado ao agachamento unipodal assistido para reeducação neuromotora.

© Todos os direitos reservados

5. Testes Ortopédicos — Joelho, Tornozelo e Pé

Avaliação ligamentar, meniscal e tendínea do membro inferior.

Nome do Teste	Estrutura Avaliada	Como Executar e Sinal Positivo	Mapa de Elétrodos Recomendado
Teste de Lachman	Lig. Cruzado Anterior (LCA)	Joelho a 20–30°: translação anterior da tíbia sobre o fémur -> Fim de curso mole	Mapa NMES Vasto Medial Oblíquo (VMO)
Teste de McMurray	Menisco Medial e Lateral	Flexão máxima + rotação externa (medial) ou interna (lateral) + extensão -> Estalido doloroso	Mapa Joelho Peripatelar (4 Elétrodos)
Apreensão Patelar	Instabilidade Femoropatelar	Deslocamento lateral passivo da rótula com joelho a 30° -> Contração de defesa	Mapa Reforço Seletivo VMO + Reto Fem.
Gaveta Anterior Tornozelo	Lig. Talofibular Anterior	Pé em leve flexão plantar: puxar calcâneo anteriormente -> Translação excessiva	Mapa Tornozelo Lateral / Fibulares
Teste de Thompson	Integridade Tendão Aquiles	Decúbito ventral: compressão manual da barriga dos gémeos -> Ausência de flexão plantar	Mapa Gémeos / Tendão de Aquiles
Teste de Windlass	Fascite Plantar	Extensão passiva da 1ª metatarsofalângica em carga -> Dor na inserção calcânea	Mapa Planta do Pé / Arco Medial

PONTO DE ATENÇÃO CLÍNICA E SEGURANÇA:

Se o Teste de Thompson for positivo (suspeita de rotura total do tendão de Aquiles), NÃO aplique eletroestimulação motora nos gémeos e encaminhe para avaliação ortopédica.

© Todos os direitos reservados

6. Escala Visual Analógica (EVA) e Seleção da Corrente Ideal

Como cruzar a nota de dor (0 a 10) e o objetivo funcional com a corrente correta nos Mapas.

Nível de Dor / Fase	Corrente de 1ª Escolha	Frequência / Pulso	Tempo e Sensação Alvo
EVA 8 a 10 (Dor Aguda)	TENS Convencional (Portão)	80 a 120 Hz · 50 a 100 µs	20 a 30 min · Formigueiro intenso e confortável (sem mexer músculo)
EVA 5 a 7 (Subaguda)	TENS VIF ou Modulado	4 a 100 Hz · 100 a 150 µs	25 min · Evita acomodação neural durante a sessão
EVA 3 a 6 (Dor Crónica)	TENS Burst / Acupuntura	2 a 4 Hz · 180 a 250 µs	25 a 30 min · Abalos rítmicos visíveis para libertar endorfinas
Inibição Artrogénica (Pós-Op)	NMES (FES) Sincronizado	35 a 50 Hz · 250 a 300 µs	ON 6s / OFF 12s · Contração visível associada ao comando voluntário
Hipotrofia Muscular	Corrente Russa ou Aussie	Aussie 1kHz / 50Hz	ON 8s / OFF 16s · 15 a 20 min · Contração forte tolerável
Edema Localizado	NMES Bomba Muscular	10 a 20 Hz · 200 µs	Recíproco ou rítmico 15 min com membro elevado

PONTO DE ATENÇÃO CLÍNICA E SEGURANÇA:

Registe sempre a EVA antes e imediatamente após a sessão na Ficha de Evolução para comprovar a eficácia analgésica ao paciente.

© Todos os direitos reservados

7. Ficha de Avaliação Fisioterapêutica Estruturada (Modelo Imprimível)

Roteiro completo de anamnese, exame físico e planeamento eletroterapêutico.

Bloco da Avaliação	Campos a Preencher na Consulta Inicial	Objetivo do Registo	Frequência
1. Identificação e Queixa	Nome, idade, profissão, desporto, Queixa Principal (QP) e tempo de evolução	Contextualizar sobrecarga mecânica	1ª Sessão
2. Triagem de Segurança	Pacemaker? Gestante? Epilepsia? Neoplasia? Implante metálico? Alteração de sensibilidade?	Descartar contraindicações absolutas	Obrigatório 1ª Sessão
3. Mapa da Dor e EVA	Localização exata, irradiação, EVA em repouso (0–10) e EVA ao movimento (0–10)	Linha de base mensurável	Todas as sessões
4. Exame Físico	ADM ativa/passiva, Força Muscular (Grau 0 a 5 MRC) e Testes Ortopédicos Positivos	Diagnóstico cinético-funcional	A cada 5 sessões
5. Plano Eletroterapêutico	Mapa nº [Nome], Corrente, Frequência (Hz), Largura (us), Canais (CH1–CH4) e Tempo	Padronizar atendimento na clínica	Todas as sessões
	Cinesioterapia,		

PONTO DE ATENÇÃO CLÍNICA E SEGURANÇA:

Podes imprimir esta estrutura ou preenchê-la digitalmente no tablet junto com a Ficha de Evolução do Paciente.

© Todos os direitos reservados

8. Termo de Consentimento Informado para Eletroterapia (Modelo Pronto

Texto padrão para assinatura do paciente no início do tratamento fisioterapêutico.

Cláusula do Termo	Texto de Referência para o Paciente	Confirmação	Validade
1. Natureza do Procedimento	Declaro que fui informado(a) sobre a aplicação de recursos de eletrotermofototerapia (TENS, NMES, Ultrassom, Laser).	[ ] Ciente	Todo o plano
2. Questionário de Segurança	Confirmo que informei ao fisioterapeuta se possuo pacemaker, gravidez, implantes, epilepsia ou perda de sensibilidade.	[ ] Confirmado	Obrigatório
3. Sensação Esperada	Compreendo que deverei comunicar imediatamente qualquer sensação de ardor, choque desconfortável ou calor excessivo.	[ ] Ciente	Cada sessão
4. Higiene e Cuidados da Pele	Fui orientado(a) a não comparecer com cremes, óleos ou loções na região e autorizo a higienização prévia do local de aplicação.	[ ] Autorizado	Cada sessão

PONTO DE ATENÇÃO CLÍNICA E SEGURANÇA:

Manter o Termo de Consentimento assinado e o questionário de contraindicações preenchido protege o profissional e transmite altíssima credibilidade ao paciente.

© Todos os direitos reservados

9. Guia de Integração Total: Avaliação -> Mapa de Elétrodos -> Alta

Fluxo de trabalho em 5 passos para sessões mais rápidas, seguras e padronizadas.

Passo do Fluxo	Ação Prática na Sessão (Tempo Estimado)	Ferramenta do Kit	Resultado Clínico
Passo 1 (2 min)	Aplicar 1 ou 2 Testes Ortopédicos específicos + medir EVA (0–10)	Páginas 2 a 6 deste Guia	Alvo anatómico confirmado
Passo 2 (30 seg)	Abrir o Atlas ElectroMapas na região correspondente e ver CH1/CH2	Atlas +58 Mapas (ciano/laranja)	Zero dúvida no posicionamento
Passo 3 (1 min)	Ajustar Hz, µs e tempo conforme a fase aguda/subaguda/crónica	Guia Rápido de Parâmetros	Dose eletrofisiológica exata
Passo 4 (15–25 min)	Executar aplicação (isolada ou associada a exercício ativo / Laser / US)	Guias de Ultrassom e Laser	Máxima eficácia terapêutica
Passo 5 (1 min)	Anotar parâmetros usados e EVA final na Ficha de Evolução	Ficha de Evolução do Paciente	Histórico impecável para a próxima sessão

PONTO DE ATENÇÃO CLÍNICA E SEGURANÇA:

Com este ecossistema completo, tens em mãos toda a referência visual de Eletroterapia, Ultrassom, Laserterapia e Avaliação Ortopédica.

© Todos os direitos reservados